

TEMA 2.1 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Tipos de Diabetes

PERFIL EUNACOM 1.04.1.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tipos de Diabetes Mellitus

Clasificación

TABLA 2.1.1: TIPO VS MECANISMO			
TIPO	MECANISMO	POBLACIÓN	CARACTERÍSTICAS
DM Tipo 1	Autoimmune → destrucción células β	Niños (90% DM infantil)	Severa, debut frecuente como CAD
DM Tipo 2	Resistencia a la insulina	Adultos con obesidad	Más frecuente; responde a HGO
LADA	Autoimmune (igual DM1 pero tardía)	Adultos jóvenes delgados	No responde a HGO; manejo con insulina
MODY	Genética autosómica dominante	< 25 años; múltiples generaciones	Benigna; responde a HGO
Gestacional	Resistencia por lactógeno placentario	Embarazadas	Ver clase específica
Otros	Corticoides, pancreatectomía, Cushing, hipertiroidismo	Variable	Tratar causa

Diferenciación DM1 vs. DM2

TABLA 2.1.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	DM1	DM2
Edad	Niño/adolescente	Adulto (> 30 años)
Peso	Normal o bajo	Obesidad frecuente
Severidad	Alta	Variable (puede ser leve)
Anticuerpos	Positivos (anti-GAD, anti-insulina)	Negativos
Péptido C	↓ (no produce insulina propia)	↑ (hiperinsulemia por resistencia)
Respuesta a HGO	No responde	Responde

Casos clínicos tipo

TABLA 2.1.3: CASO VS DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE	
CASO	DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE
8 años, delgado, polidipsia, glicemia 350	DM tipo 1
45 años, obeso, madre diabética, glicemia 130	DM tipo 2
20 años, delgada, hipotiroidismo Hashimoto, glicemia 300	LADA (autoimmune adulto)

| 20 años, delgado, padres y primos diabéticos antes de 40 años | **MODY** (genética) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 22 anos, sin antecedentes de obesidad, con IMC 22, antecedente de hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, consulta por polidipsia y baja de peso. Se constata glicemia de ayuno en 310 mg/dL. ¿Cual es el diagnostico mas probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tipos de Diabetes. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diabetes tipo 1: autoimmune, 10% de los casos, afecta niños. Tipo 2: resistencia a la insulina, mas frecuente en adultos, asociada a obesidad.
- LADA: autoimmune latente del adulto, igual a tipo 1 pero en adultos. MODY: genetica, autosomica dominante, diagnostico antes de los 25 anos.
- Diabetes gestacional: por hormonas de contrarregulacion (lactogeno placentario). Pregestacional: diagnosticada antes del embarazo o primeras 12 semanas con criterios de no embarazada.
- Diferenciacion clinica: edad, peso, severidad, respuesta a hipoglicemiantes. No se hace con un examen especifico.
- Peptido C: elevado en tipo 2 (resistencia a insulina), bajo en tipo 1, LADA y causas pancreaticas.
- Anticuerpos (anti-GAD, anti-insulina, anti-IA2, anti-ZnT8) positivos orientan a diabetes autoimmune.
- LADA se sospecha en adulto joven, sin obesidad, con autoinmunidad previa, glicemia muy alta y mala respuesta a hipoglicemiantes.
- MODY se sospecha cuando hay multiples familiares jovenes y flacos con diabetes (patron autosomico dominante).
- Otras causas: corticoides, dano pancreatico (cirugia, cancer, pancreatitis), enfermedades endocrinas (Cushing, hipertiroidismo, acromegalia).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TIPOS DE DIABETES)**PREGUNTA 1**

Paciente de 22 años, sin antecedentes de obesidad, con IMC 22, antecedente de hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, consulta por polidipsia y baja de peso. Se constata glicemia de ayuno en 310 mg/dL. ¿Cual es el diagnostico mas probable?

- A)** Diabetes mellitus tipo 2
- B)** Diabetes mellitus tipo 1
- C)** Diabetes mellitus tipo LADA
- D)** Diabetes mellitus tipo MODY
- E)** Diabetes mellitus gestacional

PREGUNTA 2

Paciente de 18 años consulta por hallazgo de glicemia de ayuno en 145 mg/dL. Tiene IMC de 22, ambos padres y un hermano son diabeticos diagnosticados antes de los 30 años, ninguno con obesidad. ¿Cual es el tipo de diabetes mas probable?

- A)** Diabetes mellitus tipo 1
- B)** Diabetes mellitus tipo 2
- C)** Diabetes tipo LADA
- D)** Diabetes tipo MODY
- E)** Diabetes por farmacos

PREGUNTA 3

¿Cual de los siguientes exámenes refleja mejor los niveles de insulina endogena para diferenciar el tipo de diabetes?

- A)** Hemoglobina glicosilada
- B)** Insulinemia basal
- C)** Peptido C
- D)** Anticuerpos anti-GAD
- E)** Glicemia de ayuno

RESUMEN: TIPOS DE DIABETES

La diabetes mellitus se clasifica en varios tipos. La tipo 1 es autoinmune, afecta principalmente a niños y representa solo el 10% de los casos. La tipo 2 es la mas frecuente en adultos, causada por resistencia a la insulina, donde la obesidad juega un rol fundamental en su fisiopatología. Existen además tipos menos frecuentes como la diabetes LADA (autoinmune latente del adulto), que es igual a la tipo 1 pero aparece en adultos y es menos agresiva, y la diabetes MODY, que es genética, autosómica dominante, diagnosticada habitualmente antes de los 25 años. En el embarazo existen dos formas: la diabetes mellitus gestacional, causada por resistencia a la insulina inducida por hormonas de contrarregulación como el lactogéno placentario, y la diabetes pregestacional, diagnosticada antes del embarazo o en las primeras 12 semanas con criterios de persona no embarazada. Otras causas incluyen farmacos (corticoides), dano pancreático (pancreatectomía, cáncer, pancreatitis) y enfermedades endocrinas que aumentan hormonas de contrarregulación (Cushing, hipertiroidismo, acromegalia). La diferenciación entre tipos se hace clínicamente: edad, peso, severidad, respuesta a hipoglucemiantes orales. Si es joven, severa, con cetoacidosis, sugiere autoinmune (tipo 1 en niños, LADA en adultos). Si tiene familiares flacos y jóvenes todos diabeticos, sugiere MODY. Los exámenes complementarios incluyen el péptido C (elevado en tipo 2, bajo en tipo 1 y LADA), anticuerpos (anti-GAD, anti-insulina, anti-IA2, anti-ZnT8) para confirmar causa autoinmune, y tests genéticos para MODY.